

✎ 침구의학 SUMMARY 공지사항

- 시험문제는 주로 질환 비교나 치료법(치료혈) 위주로 나옵니다.
- 회색 설명은 딱히 중요하지 않습니다.

✎ 침구의학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 기출: 빨간색
- 중요한 내용: 파란색

▶ 오늘의 진도

[제 3장. 소화기계 질환]

- 제 7절. 광란: ①개요 ②서양의학적 이해 ③한의학적 고찰
- 제 8절. 설사: ①개요 ②서양의학적 이해 ③한의학적 고찰
- 제 9절. 이질: ①개요 ②서양의학적 이해 ③한의학적 고찰
- 제 10절. 변비: ①개요 ②서양의학적 이해 ③한의학적 고찰

제 7절. 霍亂(광란)

1. 개요

- 휘곽변란(揮霍變亂)을 말하는 것으로, 온몸이 휘돌리고 변동이 심하여 인체의 정상생 리 상태가 교란된 상태
- ㄱ 광(霍): 오질지비성(烏疾飛之聲; 새가 푸드덕하는 소리)
- ㄴ 란(亂): 분란(紛亂)·요란(撩亂)
- 병정이 급격하고, 상토하사(上吐下瀉; 위로는 토하고, 밑으로는 설사)가 번갈아 나타남 (복통이 있기도 없기도 함)
- 원인
 - 주로 여름, 가을에 시행역려(時行疫癘)를 감수하여 역독(疫毒)이 음식을 따라 들어와 비 위가 손상되어 유발(승강(升降)기능의 문란, 청탁(淸濁)이 서로 간섭하여 발생)
 - 음식불결, 감수한냉(感受寒冷), 장위불화(腸胃不和) 등
 - 추울 때 발생하는 것은 복서(伏暑)로 인한 것
- 구분: 습광란(濕霍亂) / 건광란(乾霍亂)
- 이질(裏急後重이급후중, 赤白膿血적백농혈), 토사(吐瀉)(cf. 광란은 병정 급박함)와 감별해야 함
- +) 이급후중: 변을 보고나서도 항문이 묵직함 / 토사: 광란보다는 약한 것

2. 서양의학적 이해

- 광란: ㄱ 급성 위장염, 식중독, 식품감염증 및 전염성 질환인 콜레라(cholera)
- (1) 식중독: 음식의 섭취와 관계된 감염성/독소형 질환
 - 세균에 오염된 음식을 섭취한 후 발생
 - 원인균: 포도상구균, 살모넬라, 대장균, 비브리오 등
 - 증상: 구토, 설사 등의 소화기계 증상 + 원인균에 따라 발열, 신경마비 등 전신증상이 병발되기도 함
- (2) 콜레라: 콜레라균의 감염으로 유발되는 전염성 감염 질환
 - 원인: 대부분 구토물, 분변 등으로 오염된 음식 또는 물에 의해 감염
 - 증상: 설사, 오심, 구토 등
 - 일반적으로 복통을 동반하지 않으나, 심한 설사로 인한 전해질의 손실이 복부근육의 경련 유발가능(→ 복통 동반)
 - 진단: 분변 배양검사를 통해 진단
 - 초기 적절한 치료를 통한 탈수 진행 억제 필요
 - 전파방법: 오염된 급수에 의해 발생. 오염된 손/식기/파리 통해 입으로 감염
 - 전파기간: 발병 후 7~14일은 전염성O / 잠복기: 수 시간~5일(보통 3일)
 - 유행계절: 열대에서는 우기 / 온대에서는 여름~가을
 - 병리상태
 - 탈수 심함(눈 함몰, 피부 탄력 상실, 입술, 코, 손발 끝 cyanosis(청색증))
 - 주된 병변은 소장에 발생 → 장관 내에 점액편, 점막상피세포가 포함된 쌀뜨물 같은 액체가 들어있음 → 소장점막: 발적, 종창, 출혈반 / 비장: 위축 / 간: 혼탁종창
 - 증상
 - 돌발적이며 심한 설사와 구토로 시작
 - 장명, 빈뇨, 하루 10~20회 정도의 설사(하루 수~수십회, 쌀뜨물 같고 무취, 점액편이 흔재)
 - 복통이나 후중감은 별로 없음(이질과 다른 특성)
 - 심한 구갈, 피로, 배장근(排腸筋)의 동통성 경련, 함몰된 눈, 사성(嗟聲), 무성(無聲) 등
 - ㄱ 경미한 경우: 1~2일에 소실
 - ㄴ 중증: 탈력, 현기(暈), 실신, 체온저하, 냉한(冷汗), 배장근 경련, 흥분상태, 단백뇨 등
 - 고열, 의식장애 등의 티푸스양(樣) (설사 없고 중독된 경우): 수시간 내 사망하기도

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 원인

· 凡人內素有鬱熱범인내소유열, 外又感寒외우감한, 一時陰陽錯亂熱病일시음양착란열병, 本因飲食失節본인음식실절, 生冷過度생랭과도, 以致濕熱內甚이치습열내심, 中焦失運 중초실운, 不能升降불능승강, 是以上吐下瀉시이상토하사.

- +) 사람이 평소에 안에 열이 있다가, 외부에서 감한하게 되면, 일시의 음양이 착란되어 열병이 생기는데, / 원래 병인은 음식실절, 생랭과도한 것이 습열에 이르게 돼 안에서 심해져서, 중초가 운행을 잃어, 승강하지 못하게 되고, 이런 것들이 이르러 상토하사하게 된다.

· 或因飲冷혹인음냉, 或冒寒혹모한, 或失飢혹실기, 或大怒혹대노, 或乘舟車혹승주차, 傷動胃氣상동위기, 令人吐瀉영인토사

- +) 혹은 음냉, 모한, 실기, 대노, 승주차(배나 차를 타는 것)에 의해서도 생길 수 있는데, 위기를 상하게 하고 동하게 하여, 사람으로 하여금 토사를 일으킨다.

(2) 증상

· 心腹卒痛심복졸통, 嘔吐下利구토하리(或不吐不瀉혹불토불사), 增寒壯熱증한장열, 頭痛眩暈두통현훈, 先心痛則先吐선심통즉선토, 先腹痛則先利선복통즉선리, 心腹俱痛 심복구통, 吐利並作토리병작, 甚則轉筋入腹即死심즉전근입복즉사

- +) **심복졸통**: 심복부 졸통 / **구토하리**: 구토와 설사(혹불토불사: 토나 설사를 안 하는 경우도 있음) / **증한장열**: 오한&발열이 심하게 나타남

- +) **선심통즉선토**: 가슴이 먼저 아프면 먼저 토함 / **선복통즉선리**: 복통이 먼저 있으면 먼저 설사 / **심복구통 토리병작**: 심복에 모두 통증이 있으면 토와 설사가 같이 나타남 / **심즉전 근입복즉사**: 이게 심해지면 전근이 되어 배에 들어가면 죽게 됨

(3) 분류

· ① **습곽란(濕霍亂)** - 우리가 알고있는 전형적인 곽란

- **증상**: 上吐下瀉상토하사 皆吐利則개토리즉 所傷之物소상지물 得以泄出득이설출 雖甚重수심중 胃中水穀위중수곡 泄盡則止矣설진즉지의 所以死者少소이사자소

→ +) **상토하사**: 위로는 토, 아래로는 설사

→ +) **개토리즉 소상지물 득이설출 수심중 위중수곡 설진즉지의**: 토리(토+설사)하게 되면

상한 물질을 모두 뱉어내는 것으로, 그러면 비록 증상이 심해보이지만, 위의 수곡이 모두 나오게 되면 증상은 그치게 됨

→ +) **소이사자소**: (그렇기 때문에, 증상이 심해보여도) 죽는 사람은 적음.

- **치법**: 和胃行水화위행수, 辟穢泄濁벽예설탁

- **치료혈**: 少商소상 關衝관충(出血) 合谷합곡 曲池곡지 承山승산 委中위중

→ +) 그래도 급증이니 정혈 다용: 소상(폐경의 정혈), 관충(삼초경의 정혈)

→ +) 승산, 위중: 대장질환에 다용

· ② **건곽란(乾霍亂)** - 토하거나 설사하는 게 없는 사람

- **증상**: 吐利不得토리부득. 死者多者사자다자 以其上不得吐이기상부득토 下不得利 하부득리 則所傷之物즉소상지물 不得泄瀉부득설사 壅閉正氣옹폐정기 隔絕陰陽 격절음양 煩擾悶燥번요민조 喘脹而死矣천창이사의

→ +) **토리부득 사자다자**: 토하고 설사하는 걸 얻지 못하여 죽는 사람이 많음

→ +) **이기상부득토 하부득리 즉소상지물 부득설사 옹폐정기 격절음양 번요민조 천창이사의**: 위로는 토하지 못하고, 아래로는 설사하지 못하니, 상한 물질이 밖으로 나오지 못해서, 정기가 막히게 되고, 음양이 끊어지게 되고, 번요민조하게 되고, 천식이나 부풀어오르는 것이 생기면서 죽게 됨

⇒ 즉 감염된 원인 물질이 차라리 밖으로 빠져나오면 괜찮은데, 그러지 못하고 독소/사가 몸 안에 있으면서 정기가 막히게 되어 사망하게 되는 것

- **치법**: 辟穢泄濁벽예설탁, 利氣宣壅이기선옹

- **치료혈**: 十宣穴십선혈 人中인중 少商소상 委中위중 合谷합곡 太衝태충 間使간사 中脘중완 曲池곡지 ← 습곽란보다 훨씬 급증 ⇒ ∴응급혈 사용(십선혈, 인중)

· ③ **한곽란(寒霍亂)**

- **증상**: 腸胃交通장위교통 或吐或瀉혹토혹사 四肢厥冷사지궤냉 面靨靑白면순청백

- **치법**: 溫中散寒온중산한, 補氣益陰보기익음

- **치료혈**: 神門신문(灸(:한증)) 中脘중완 合谷합곡 太衝태충 委中위중

→ **토者토자**: 內關내관 內庭내정 足三里족삼리

→ **瀉者사자**: 天樞천주 章門장문 陰陵泉음릉천 崑崙곤륜

→ **轉筋전근**: 承山승산 絕骨절골 太衝태충

· ④ 열곽란(熱霍亂)

- **증상:** 發熱煩渴발열번갈 氣喘胸悶기천흉민 上吐下瀉상토하사
- **치법:** 清熱化濕정열화습, 辟穢泄瀉벽예설탁
- **치료혈:** 少商소상 關衝관충 委中위중(出血) 合谷합곡 大都대도 曲池곡지 陰陵泉 음릉천 中脘중완 絕骨절골

(4) 곽란 후 제증(霍亂後諸症)

· ① 곽란후전근(霍亂後轉筋)

- **원인:** 暴吐暴瀉폭토폭사, 津液速亡진액속망, 宗筋失其所養종근실기소양
→ +) 갑자기 토하고 갑자기 설사하면서, 진액이 갑자기 속망하게 되어, 종근이 그 영양분을 공급받지 못해 발생
- **증상:** 輕者兩脚轉筋경자양각전근 重者遍體轉筋入腹중자편체전근입복 手足厥冷 수족궤냉 危甚風燭위심풍촉
→ +) 경자양각전근 중자편체전근입복: 가벼우면 양 다리만 전근이 나타나고, 심하면 배까지 들어가게 됨
→ +) 위심풍촉: 위급함이 심하면 바람 앞의 촛불과 같다
- **치법:** 清血養筋정혈양근, 疎肝補脾소간보비
- **치료혈:** 委中위중 關元관원(刺出血) 絕骨절골 太衝태충 三陰交삼음교 中封중봉 承山승산 承筋승근 足外踝骨尖족외과골첨(灸) → +) 전근에 위중, 승산, 승근 같이 많이 사용

· ② 곽란후번갈(霍亂後煩渴)

- **원인:** 吐瀉既多토사기다, 津液暴亡진액폭망
- **증상:** 煩渴引飲不止번갈인음부지
- **치법:** 益陰止渴익음지갈 → 진액 보충

· ③ 곽란후허번(霍亂後虛煩)

- **원인:** 因吐瀉인토사, 津液消失진액소실, 虛火上升허화상승
→ +) 토사로 인해 진액이 소실되어 허화가 상승
- **증상:** 虛煩不得眠허번부득면 或熱渴혹열갈
→ +) 허번으로 인해 잠을 자지 못하고, 열이 나면서 갈증도 남
- **치법:** 清血益陰養神정혈익음양신

제 8절. 泄瀉설사

1. 개요

- =복사(腹瀉), 배변 횟수가 점차 증가하고 분질(糞質)이 묽거나 완곡불화(完穀不化) 또는 수양성(水樣性)의 희박(稀薄)한 변을 배출하는 것

· 원인

- 설사는 비위의 기능과 밀접한 관계
- 脾(主運化), 胃(水穀之海)에 사기가 들어와 습체응취(濕滯凝聚)하여 하주(下注)
- **급성:** 생냉불결(生冷不潔)한 음식 섭취, 한습서열(寒濕暑熱)의 사기가 장위에 머물러 기기 불 화(氣機不和), 장위의 운화 전도에 문제 생겨 청탁불분(淸濁不分)하여 발생
- **만성:** 비위허약 / 간기(肝氣)가 비토(脾土)를 억제하지 못함 / 신양부진(腎陽不進)으로 명문 화가 허약하여 비토를 따뜻하게 하지 못함으로 수습이 적체, 장간(腸間)으로 넘쳐 발생
- 변조불안(煩燥不安), 호흡이 깊고 맥미약(脈微弱) 사지궤냉(四肢厥冷) 등 증상: 산중독 (酸中毒)이나 전해질 대사의 이상이 심한 것 → 위급한 상태 발생 가능하므로 적절한 응급치료 필요함

· 심한 설사의 경우, 체내 수분 감소 방지를 위한 적절한 수분공급 고려

- 이질과 감별 필요

2. 서양의학적 이해

- **장내 액체성분의 정상적 흐름과 장점막을 통한 이동의 장애로 인해 발생**
- +) =장에서 수분이 흡수돼야 하는데, 어떤 원인으로든 흡수가 안 되는 것
- **설사는 대변 횟수와 대변 내 수분량이 증가된 경우를 말함**(배변 횟수가 하루 4회 이상, 대변량 하루 250g 이상이거나 대변 내 수분량이 200ml 이상)
- ***정상: 대변 1주 3회~1일 3회, 50g~ 250g까지**
- **급성 설사:** 2~3주 이내에서 지속되는 설사
- **원인:** 주로 약제 및 음식물 중의 독소, 중금속, 세균이나 바이러스 등의 감염, 흡수 장애 등과 관련
- 세균성 설사의 경우 세균검사를 통해 원인의 50~80% 감별가능
- **만성 설사:** 2~3주 이상 지속되는 설사
- **원인:** 알코올 및 약제, 궤양성 혹은 염증성 장 질환, 허혈성 장염, 과민성 장증후군, 흡수 장애, 만성 세균성 감염, 방사선 대장염, 갑상선 질환, 수술 후 증후군 등과 관련
- **기전:** 장관 내 삼투압 증가에 의한 장관 내 수분 증가, 활동성 전해질 분비, 장점막의 구

조적 손상, 여과의 증가, 장관운동의 이상

· 가성설사와 대변실금과 구별 필요

- **가성설사**: 하루 3~4회 이상 배변, 그러나 전체 배변량은 정상 → ex. 과민성 장증후군, 직장염, 갑상선 기능항진증 등

- **배변 실금**: 항문 직장 또는 골반 근육의 이상으로 인한 수의적 배변 조절 불능으로 본인 의사와 관계없이 자주 배변. 배변량은 정상

→ +) ex. 소변 보면서 대변도 나오는 경우, 방귀뀌면서 대변 나오는데 본인이 인지X

· 기전의 분류

- ① **삼투성 설사(osmotic diarrhea)** = 삼투압 차이로 인한 설사

→ 장관내에 흡수가 잘 안되거나 불가능한 물질의 농도가 높을 때, 장관내 삼투압의 증가로 수분이 흡수되지 않아 발생 = 대장 안에 삼투압이 높은 물질이 있는 것

→ 대변의 대부분은 수분 + 흡수되지 않은 물질로 구성

→ 삼투압 유발 물질 섭취 시(설사제), 취장질환, 유당 불내증 등

- ② **분비성 설사(secretory diarrhea)** = 삼투압과 상관없이 장 안에 안 좋은 물질이 있는 것

→ 장점막의 구조적 손상 없이 세균성 독소, 담즙산, 지방산, 설사제 등에 의해 장관 내로 수분 및 전해질 분비가 증가되어 발생

→ 대변량이 많고 금식 중에도 설사가 지속됨. 물설사가 많음. 콜레라 등

- ③ **삼출성 설사(exudative diarrhea)** = 장에 손상이 와 흡수되는 공간이 부족해서 발생

→ 장관의 절제 또는 염증으로 장점막의 구조적 손상 있을 때 수분 및 전해질의 흡수장애로 발생

→ 조직 파괴 시 일어나는 출혈로 혈성설사 동반할 수 있음

→ 분비성 설사와 양상 비슷하나 대변 내 염증세포나 혈액 관찰됨

→ 만성 염증성 장질환(궤양성 대장염, 크론병 등), 세균이나 원충 감염

- ④ 여과의 증가

→ 장폐쇄시 장관내압증가로 정맥 및 림프 흐름에 장애가 일어나 수분이 장관내로 이동하여 발생

- ⑤ 장운동 장애

→ 절제위, 과민성대장, 당뇨병 등의 만성설사

· 원인부위에 따른 양상

- **좌측(하행결장, 직장, S상 결장)** [대장의 끝 부분]

→ 좌측의 대장은 대변의 저장고 역할

→ 좌측의 염증성 병변이 있을 때

→ 변이 조금만 차도 자극받아 배변 횟수가 잦고 대변량이 적음, 변의가 있을 때 복통이 있고 후증이 심함

→ **급성**: 세균성 이질 / 만성: 궤양성 대장염

- **우측(소장, 상행결장)** [장의 시작 부위, 소장]

→ 배변횟수 많지 않고 한번의 대변량이 많음. 배변 전에는 복통이 있을 수 있으나 배변 후에는 후증 없음

→ 영양흡수장애균에 의한 설사, 살모넬라증 등

· 기타 대변의 양상

- 악취, 유동성 있으며 음식물 입자를 포함하는 미끌미끌한 대변 → **흡수부전**

- 육안적 혈변 → **염증이나 신생물(ex. 암)**

- 쌀뜨물 형태 → **cholera, rota virus(젓먹이, 유아의 설사)**

- 점혈변 → **궤양결장염, 세균이질 (cf. 크론병은 설사, 혈변 있으나 점혈변은 없음)**

- 딸기젤리모양 → **이질아메바**

· +) 설사: 대장 (가장 多) → 소장 → 취장 순으로 의심해보기

- ㄱ **대장 끝 부분**: 자주 보고, 후증

- ㄴ **소장**: 물설사 (like 쌀뜨물), 가스가 많이 참

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 급·만성 설사

· ① 급성 설사

- **증상:** 발병이 급하고 배변횟수가 갑자기 많아지며 대변은 묽거나 물 같은 변이고, 복통, 발열, 두통, 식욕부진, 구토 등의 증상을 수반하며, 병정이 대개 2개월 이내

→ **한습자(寒濕者):** 大便清稀대변정희 水穀相雜수곡상잡 腸鳴腹痛장명복통 口不渴 或渴喜熱飲구불갈혹갈희열음 身寒喜溫신한희온 舌苔白膩설태백니 脈濡緩맥유완 甚則腹瀉無度심즉복사무도 四肢逆冷사지역냉 脈沈細或沈伏맥침세혹침복

⇒ +) **대변정희:** 대변이 맑고 묽음 / **수곡상잡:** 수곡이 섞여있음 / **구불갈혹갈희열음:** 갈증이 없거나, 따뜻한 걸 마시는 걸 좋아함 / **심즉복사무도:** 심하면 설사가 정신없이 계속 나옴

→ **습열자(濕熱者):** 黃色泄瀉황색설사 混粘液便혼점액변 肛門灼熱항문작열 小便短赤 소변단적 口渴喜冷飲구갈희냉음 舌苔黃膩설태황니 脈濡數맥유삭

⇒ +) **혼점액변:** 혼탁한 점액변을 보 / **구갈희냉음:** 목마르고 차가운 물 마시는 걸 좋아함

→ **식체자(食滯者):** 糞便臭如敗卵분변취어패란 瀉後痛減사후통감 不消化物불소화물 脘腹痞滿안복비만 噯腐酸臭애부산취 不思飲食불사음식 舌苔厚膩설태후니 脈滑맥활

⇒ +) **분변취어패란:** 분변에서 계란 썩는 냄새 / **사후통감:** 대변을 보고 나면 통증 경감 / **불소화물:** 소화되지 않은 음식물이 보임

- **치법:** 祛邪消食거사소식, 調整腸胃氣機조정장위기기

- **치료혈:** 天樞천추 合谷합곡 陰陵泉음릉천 上巨虛상거허 下巨虛하거허 梁丘양구

- **치료혈:** 수족양명경혈 위주로 취함. 침구사법, 한증: 加 灸 / 열증: 可放血(자락요법)

→ **한습설사:** 梁門양문 關門관문(溫鍼온침)

→ **습열설사:** 曲池곡지 大椎대추 內庭내정, 혹 熱甚(열이 심하면) 加 商陽상양(點刺 放血점자방혈) - 열을 내리는 혈자리들

→ **식체장위:** 上廉상렴 下廉하렴 中脘중완

· ② 만성 설사

- **증상:** 병세가 완만하고, 매일 설사하나 횟수는 적음. 지속적이거나 반복적으로 배변 횟수가 많고 대변은 묽으며, 체중감소, 영양불량, 빈혈 등을 수반, 병정은 대개 2개월 이상

→ **비허자(脾虛者):** 大便溏薄대변당박 水穀不化수곡불화 飲食減少음식감소 腹滿腸鳴 복만장명 面色萎黃면색위황 肢倦乏力지권필력 舌淡苔白설담태백 脈細弱맥세약

→ **간기승비(肝氣乘脾)(간기범위(肝氣犯胃)자:** 胸脇脹悶흥협창민 噯氣食少애기식소 情志抑鬱정지억울 腹痛泄瀉복통설사 舌淡紅설담홍 脈弦맥현 - 스트레스와 관련

→ **신허자(腎虛者):** 五更泄瀉오경설사 畏寒외한 腰膝酸軟요슬산연 脈沈細맥침세 舌淡苔白설담태백

- **치법:** 健脾건비(→비허자), 疏肝소간(→간기승비자), 溫腎온신(→신허자)

- **치료혈:** 中脘중완 關元관원 天樞천추 足三里족삼리

- **치료혈:** 임맥·족양명경혈과 배수혈 취혈. 침구보법

→ **비허(脾虛):** 加 脾俞비수 胃俞위수 關元俞관원수 公孫공손

→ **간울(肝鬱):** 加 肝俞간수 行間행간 陽陵泉양릉천

→ **신허(腎虛):** 加 腎俞신수 命門명문

→ **완비(脘痞):** 加 公孫공손

→ **협통(脇痛):** 加 陽陵泉양릉천

→ **단기여천(短氣如喘):** 加 氣海기해

(2) 분류

· ① 습설(濕泄)

- **증상:** 腸鳴身重장명신중 洞泄如瓶水傾下동설여병수경하 腹不痛或微痛복불통혹미통 胸悶흥민 口不渴구불갈 小便少소변소 脈濡細맥유세 舌苔白淡설태백담

→ +) 수분이 많은 증상들 - **장명신중:** 배에서 소리가나고 몸이 무거움 / **동설여병수경하:** 항아리에서 물을 따르는 것처럼 설사 / **복불통혹미통:** 복통이 없거나 약간만 아픔

- **치법:** 溫中利濕온중리습

- **치료혈:** 水分수분 陰陵泉음릉천 公孫공손 脾俞비수 - 습기 제거 시 쓰는 혈들

· ② 한설(寒泄)

- **증상:** 惡寒身重오한신중 腹脹切痛복창절통 腹中雷鳴복중뇌명 鴨瀉淸冷압당청냉 完穀不化완곡불화 喜溫喜按희온희안 身寒신한 小便淸白소변청백 腹痛복통 腸鳴 장명 完穀不化완곡불화 脈沈遲맥침지 舌苔薄白설태박백
- +) **오한신중:** 추우면서 몸도 무거움 / **복창절통:** 배가 끊어질 것처럼 아픔 / **복중뇌명:** 배에서 소리가 크게 들림 / **압당청냉:** 오리 대변처럼 청냉
- **치법:** 溫中散寒利濕온중산한리습
- **치료혈:** 大腸俞대장수 天樞천추 中脘중완 氣海기해 足三里족삼리 神闕신궤 腎俞 신수 胃俞위수 章門장문 梁門양문 合谷합곡 - 배수혈과 임맥혈 같이 사용

· ③ 화설(火泄)(열설(熱泄)), 서설(暑泄)

- **증상**
- **화설:** 口乾喜冷氣건희냉 痛一陳瀉一陳통일진사일진 其來暴速기래폭속 稠粘 조점 發熱 발열 小便短赤소변단적 肛門灼熱항문작열 脈洪數맥홍삭
- ⇒ +) **통일진사일진:** 통증이 한 번 오면 설사 한 번 함 / **기래폭속:** 오는 것이 바르게 왔다 갔다 함 / **조점:** (대변이) 조점
- **서설:** 神昏面垢신혼면구 心煩口渴심번구갈 惡心嘔吐오심구토 頭暈두훈 身熱 신열 脈虛 맥허 舌苔淡설태담
- ⇒ +) **신혼면구:** 신혼하거나 얼굴에 때긴 것처럼 보임
- **치법:** 淸熱利尿청열이뇨
- **치료혈:** 合谷합곡 內庭내정 下脘하완 太白태백 太谿태계 曲池곡지 三里삼리 膽俞 담수 臨泣임읍 曲澤곡택

· ④ 허설(虛泄) - 힘이 없는 것

- **증상:** 困倦無力곤권무력 遇飲食卽瀉우음식즉사 或腹不痛혹복불통 腹滿복만 食後作瀉 식후작사 脈緩無力맥완무력 舌苔白설태백
- +) **곤권무력:** 몸이 무거우면서 힘이 하나도 없으면서 피곤함 / **우음식즉사:** 음식을 먹으면 설사 / **혹복불통:** 배가 안 아플 수도 있음 / **식후작사:** 먹고 나면 설사할 수 있음
- **치법:** 補中益氣利濕보중익기리습
- **치료혈:** 中脘중완(灸) 章門장문 脾俞비수 腎俞신수 關元관원

· ⑤ 손설(飡泄)

- **증상:** 米穀不化而泄出미곡불화이설출 日久不愈일구불유 畏寒외한 脈弱或沈細맥약 혹은 세 舌苔白설태백
- +) **미곡불화이설출:** 소화되지 않는 음식물이 보임 / **일구불유:** 시간이 오래 지나도 안 나옴
- **치법:** 溫脾益腎陽온비익신양
- **치료혈:** 陰陵泉음릉천 然谷연곡 巨虛거허 上廉상렴 隱白은백 脾俞비수

· ⑥ 구설(久泄)

- **증상:** 下痢不止하리부지 其脈沈遲기맥침지 手足厥冷수족궤냉 → 심한 증상들
- +) **하리부지:** 하리하는 것이 멈추지 않음
- **치법:** 溫脾補腎온비보신
- **치료혈:** 天樞천추 氣海기해 脾俞비수 水道수도 水分수분

2) 기타치료

(1) 기타치료혈

- ① **당설(滂泄):** 膈俞격수(灸) 腎俞신수(灸) 關元관원 公孫공손
- ② **설사삼오년불유(泄瀉三五年不愈):** 灸百會五七壯구백회오칠장 - +) 설사가 오랫동안 그치지 않으면 백회혈에 뜸
- ③ **수족냉제복통(手足冷臍腹痛, 수족이 냉하면서 제복통이 있으면):** 氣海기해(灸)

(2) 구법 → 만성 설사에 활용

- 비위허약, 한습설사에는 구법을 활용: 天樞천추 關元관원 神闕신궤에 각각 5~7장을 매일 혹은 격일로 1회 시술

제 9절. 痢疾이질

1. 개요

- **주증상:** 복통(腹痛), 이급후중(裏急後重), 적백농혈하리(赤白膿血下痢) 및 배변횟수 증가
- +) **이급:** 뒤가 몹시 급해서 수시로 대변을 보고자 하는 것 / 후중: 항문이 무겁고 빠지는 것같으면서 변을 보고도 상쾌하지 않은 것 / cf. 설사: 이급후중이 없음
- +) **적백농혈하리:** 피, 피고름이 섞인 설사
- = 장벽(腸壁), 혈일(血溢), 혈설(血泄), 혈변주하(血便注下), 청농혈(淸膿血), 설하(泄下)
- 여름과 가을에 주로 발생하는 전염질환
- 생냉(生冷) 또는 오염된 음식물, 외감으로 서습역독(暑濕疫毒)의 사기를 받은 후, 외사와 식체가 장에서 겸발(兼發)하면 대장의 전도(傳導)기능 이상이 발생, 습열성(濕熱盛)하고 기혈결체(氣血結滯)되어 장부맥락(臟腑脈絡)을 손상하여 발생
- **구별:** 습열리(濕熱痢), 한습리(寒濕痢), 금구리(噤口痢), 휴식리(休息痢)

2. 서양의학적 이해: 세균성 / 아메바성

- ① **세균성 이질:** 이질간균(shigella)으로 인한 장관전염질환
 - 유행성 / 잠복기는 1-2일 / 발병 급함 / 발열 등의 중독증상
 - 전염력이 강해 제1종 법정 전염병으로 지정됨(환자, 보균자의 분변에 오염된 식품이나물 등으로 전파, 또는 오염된 손과 물건에 접촉하여 전파)
 - 대변 횟수 증가, 소량, 복통, 이급후중이 현저, 복압통(전체적, 우하복부에 현저)
 - 점액 또는 고름 섞인 변에 신선한 피가 선상/점상으로 부착되어 있음
 - 원인균에 따라 점액변, 혈변이 적고 설사가 주증인 이질도 있음
- ② **아메바성 이질:** 아메바 기생충에 의한 감염성 질환
 - 산발적으로 발생 / 잠복기는 1주-1개월 / 발병 비교적 완만 / 발열 심하지 않음
 - 대변횟수 비교적 적으나 양은 많음, 복통, 이급후중 현저하지 않음, 우하복부에 국한된 약한 복압통
 - 점액 및 혈액이 변에 섞여 나오고 딸기젤리상을 보임. 때로 생선 내장 썩는 듯한 냄새 남
- **조리**
 - 소화가 잘 되고 찌꺼기가 적은 음식 섭취, 충분한 수분 공급(하루 2,000~ 3,000mL), 비타민류 섭취(비타민 B), 위생상태 개선 중요

+) 선진국형 / 후진국형 / 개발도상국형 이질

- **후진국형:** 전형적인 이질. 이급후중, 혈변
- **선진국형:** 소장형 대변(물설사, 이급후중 안 심함)
- **개발도상국형:** 후진국형과 선진국형이 섞인 느낌

· 한의학에서는 변증위주로 진단

- 궤양성 대장염, 결장염 등도 **복통, 이급후중, 적백농혈하리** 등 이질의 일반적인 증상이 관찰될 경우 → **한의학적 이질 범위에 속함**
- 반면 세균성/아메바성 이질이 **이급후중 없이 수양성 설사의 경향**을 보일 경우 → **한의학의 설사 범위에 포함**

참고) 만성 염증성 장 질환: 장에 만성적인 원인불명의 염증을 일으키는 질환

· 궤양성 대장염(ulcerative colitis)

- 병변이 **대장에 국한**, 병변이 **점막층에만 있으며 출혈이 주증상**
- cf. 크론병은 소장과 대장에 다발성 발현, 병변이 장 전층 침범하여 협착, 누공 일으켜 복통, 설사, 체중감소가 주증상 (크론병은 입~항문까지 전체 소화관에서 나타남)
- 점막의 부종, 발적, 출혈, 미란 및 궤양이 특징
- **주증상:** 소량. 빈번한 혈성설사, 배변 직전의 긴박한 복통, 점액변, 후중. 전신 증상 동반(발열, 체중감소 등)은 드뭄
- 30세 이하에서 다발 (소아, 50세 이상의 성인에서도 발견)
- 면역병리학적 기전과 심리학적 요인이 관여하는 것으로 추정
- 장기간 걸쳐 **대장 전체에 침범 시 악성화될 위험 있음** → 암화(canceration)될 위험 있음

· 크론병(Crohn's disease)

- 원인은 명확하지 않고, 주로 젊은층에서 나타남
- 섬유화/궤양을 동반하는 육아종성 염증성 병변(granulomatous inflammation)이 나타남
- **소화관의 어느 부위에서나 발생할 수 있음(구강~항문까지)**
- 소화관 외에, 특히 피부에도 전이성 병변이 발생하는 경우도 있음
- 임상소견은 병변부위와 범위에 따라 다름
- **소장형:** 복통 (그 외 흡수불량증후군, 지방변, 물설사(watery diarrhea))
- **대장형:** 변통 이상(혈변, 후중감)

- **대표증상:** 발열, 복통, 설사, 체중감소 → 발열, 영양장애, 빈혈, 관절염, 홍채염, 간질환 등 전신 합병증이 일어날 수 있음

3. 설사와 이질

	복통	이급 후중	노책 (努責)	점적 (點滴)	폭하 (暴下)	농혈	소화
설사	있을 수도 있고 없을 수도 있음	X	X	X	O	X	될 때도, 안 될 때도 있음 (소화 안 된 음식물이 보일 때도, 안 보일 때도 있음)
이질	O	O	O	O	X	O	X (소화 안 된 음식물이 가끔씩 보임)

- 노책: 힘을 열심히 쓰는데 대변이 안 나옴
- 점적: 방울방울 떨어지는 것
- 폭하: 갑자기 폭 떨어지는 것

4. 한의학적 고찰: 치료

1) 기본치료법

- 수족양명경 위주 / 사법 / 편한자(偏寒者) 加 灸
- 기본 경혈: 습곡합곡 天樞천주 上巨虛상거허

2) 변증치료

(1) 습열리(濕熱痢)

- 증상: 腹痛복통 裏急後重이급후중 痢下赤白膿血리하적백농혈 肛門灼熱항문작열 小便 短赤소변단적 舌苔黃膩설태황니 脈滑數맥활삭
- 치법: 清熱利濕청열리습
- 치료법: 加 曲池곡지 內庭내정 → 열이 있으므로

(2) 역독리(疫毒痢): 습열리보다 좀 더 심한 것

- 증상: 發病急聚발병급취 痢下鮮紫膿血리하선자농혈 腹痛복통 裏急後重이급후중 較濕 熱痢爲甚고습열리위심 壯熱口渴장열구갈 頭痛煩躁두통번조 舌質紅絳설질홍강 苔黃燥태황조 脈數맥삭
- 치법: 泄熱解毒설열해독
- 치료법: 加 大椎대추 十宣십선(放血) → 좀 더 위중하므로 열 내려주는 혈들

(3) 한습리(寒濕痢)

- 증상: 痢下赤白粘凍리하적백점동 白多赤少백다적소 或純爲白凍혹순위백동 伴有腹痛 반유복통 裏急後重리급후중 飲食乏味음식핍미 胃脘飽悶위완포민 頭痛困重두통곤중 舌質淡설질담 苔白膩태백니 脈濡緩맥유완
- +) 리하적백점동: 하얀 게 많이 나타나고 붉은 게 적게 나타남 / 혹순위백동 반유복통: 순수 하게 백동(흰 고름-17씨머리)만 나타나는 경우도 있고, 반 정도는 복통이 있기도 함
- 치법: 益氣化濕익기화습
- 치료법: 加 中脘중완 氣海기해, 或 陰陵泉음릉천 氣海기해

(4) 금구리(噤口痢)

- 증상: 下痢不能食하리불능식 惡心嘔吐오심구토 胸脘痞悶흉완비민 精神倦怠정신권태 舌苔黃膩설태황니 脈濡數맥유삭
- +) 하리불능식: 설사는 하는데 먹지를 못함
- 치법: 和胃止嘔화위지구
- 치료법: 加 中脘중완 內關내관 內庭내정 → 위경, 심포경 같이 사용

(5) 휴식리(休息痢): 나타났다 안 나타났다 하는 것

- 증상: 下痢時作時止하리시작시지 日久不愈일구불유 倦怠怯冷권태겁냉 嗜臥기와 舌質 淡설질담 苔膩태니 脈濡軟或虛大맥유연혹허대
- +) 하리시작시지: 때때로 시작했다 때때로 그침 / 일구불유: 시간이 지나도 낫지 않음
- 치법: 溫中清腸온중청장
- 치료법: 加 脾俞비수 胃俞위수 關元관원, 或 脾俞비수 腎俞신수 → 배수혈. 임맥 같이 사용

(6) 양허리(陽虛痢)

- **증상:** 下痢稀薄하리희박 或帶白凍혹대백동 腹部隱痛복부은통 食少神疲식소신피 四肢 不溫사지불온 腰痠怕冷요산파냉 甚至滑脫不禁심지활탈불금 舌淡설담 苔薄白태박백 脈沈細而弱맥침세이약
- +) **혹대백동:** 혹은 백동을 띠 / **복부은통:** 복부의 은은한 통증
- **치법:** 溫補脾腎온보비신
- **치료혈:** 加 脾俞비수 腎俞신수

(7) 음허리(陰虛痢)

- **증상:** 下痢赤白膿血하리적백농혈 粘稠如凍점조여동 量少難出양소난출 腹痛綿綿복통 면면 虛坐努責허좌노책 心煩口渴심번구갈 午後低熱오후저열 神疲乏力신피필력 舌質 紅설질홍 苔少태소 脈細數맥세삭
- +) **하리적백농혈:** 설사하면 적백농혈이 있음 / **양소난출:** 양이 적고 보기 힘들 / **복통면면:** 복통이 이어짐 / **허좌노책:** 힘은 쓰는데 잘 나오지 않음
- **치법:** 滋陰養血자음양혈
- **치료혈:** 加 照海조해 血海혈해

3) 기타치료혈: “읽어보세요”하고 넘어갔는데 기출

- 백리(白痢): 合谷합곡 關元관원 脾俞비수 天樞천추
- 적백리(赤白痢): 大腸俞대장수 小腸俞소장수 足三里족삼리 合谷합곡 外關외관 復溜 부류 膀胱俞방광수 白環俞백환수 中膻俞중려수
- 적백리어적(赤白痢如赤): 內庭내정 天樞천추 隱白은백 氣海기해 內關내관
- 적백리어백(赤白痢如白): 外關외관 中膻중완 隱白은백 天樞천추 申脈신맥
- 이급후중(裏急後重): 合谷합곡 外關외관
- 휴식리(休息痢): 神闕신궐 天樞천추 關元관원 小腸俞소장수 脾俞비수(灸)
- 냉리(冷痢): 關元관원 竅陰구음(灸)
- 기타: 合谷합곡 三里삼리 陰陵泉음릉천 中膻중완 關元관원 天樞천추 神闕신궐 中極 중극 大都대도(灸) 商丘상구(灸) 陰陵泉음릉천(灸)

제 10절. 便秘변비(大便秘結, 脾約, 大便不通, 大小便不通)**1. 개요**

- = 脾約비약, 大便難대변난

· 증상

- ① 분변(糞便)이 건결하여 배변이 곤란 ((대변을) 딱딱하게 봄)
- ② 장내에 분변이 오래 적체되어 배변주기가 길어지는 경우 (너무 오래 보지 않음)
- ③ 배변은 정상적이나 불창(不暢)한 증상 (보기는 하는데 시원치 않음)
- **기전:** 대장의 정상적인 전도(傳導)기능이 상실된 것. 혈중에 조열이 잠복하여 진음(眞陰)이 모산(耗散)되고 진액이 고갈되어 유발

· 원인

- ① 조열로 인한 진액손상
- ② 노권내상과 연로체쇠(年老體衰)로 인한 기혈부족
- ③ 정지실조(情志失調)로 인한 기기울체
- (장뿐만 아니라) 신, 폐, 비위와도 밀접한 관련

2. 서양의학적 이해**1) 변비**

- 배변 횟수가 3~4일에 1회 미만으로 감소하는 경우, 딱딱한 변, 배변 시 과도한 힘주기, 불완전한 배변감, 직장이나 항문의 폐쇄감

2) 변비의 진단기준

- ① 배변의 1/4에서 배변시 무리한 힘이 드는 경우
- ② 대변이 과도하게 굳은 경우
- ③ 불완전 배변감이 있는 경우
- ④ 항문직장 폐쇄감이 있는 경우
- ⑤ 배변을 용이하게 하기 위한 손동작이 필요한 경우
- ⑥ 일주일에 3번미만의 배변 횟수
- 6가지 중 2개 이상이 지난 12개월 중 적어도 12주 이상 양성인 경우 기능성 변비로 진단

3) 동반증상

- 복통, 복부 팽만감, 조기 포만감(장이 차있으므로), 고창감, 잦은 방귀, 오심, 속쓰림, 식욕 부진, 불면증, 우울증, 구강 이물감, 두통, 허약 등

4) 원인

- 대장/직장 운동의 이상, 배변 감각/반사의 둔화, 항문의 기질적/기능적 폐쇄 등
- 섬유질이 부족한 식생활, 육체/정신 장애로 인한 활동저하, 배변반사의 자의적 억제, 여행 등 생활환경의 변화, 개인의 성격 등
- +) 특히 장은 심리적 부분과 연관 多
- ex. 과민성 장 증후군
- 강박적, 완벽주의적인 성격인 사람이 장이 안 좋은 경우 많음

5) 특발성/이차성 변비

- ① **특발성 변비 (90%)**: 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않은 것
- +) But 원인을 '못' 찾는 것일 수도
- 대장/직장항문의 운동기능 이상으로 유발
- **과민성장증후군**: 주로 청장년에서 발생 / 하복부에 심한 복통 동반, 작고 딱딱한 변, 불완전한 배변감, 배변 시 힘이 많이 듦
- **대장무력증**: 대장 통과시간 지연 (72h 이상 cf. 정상: 18~72h) → 배변 횟수 감소
- **기능성 출구폐쇄증**: 원위부 대장에서 대변을 항문 밖으로 밀어내지 못함 / 배변 시 과도한 힘이 듦. 배변 시 골반저 근육 이완이 잘 안되고, 오히려 외괄약근 수축 일어나기도 함
- ② **이차성 변비**: 질환이 있어서 대변을 못 보는 것
- **대장의 국소적 질환**: 대장협착, 대장종양, 허혈성 대장염, 치질, 항문협착 등
- **전신적 질환**: 내분비 및 대사질환, 교원성 질환, 신경계질환 등
- **기질적 변비**(임신, 월경 주기의 황체기 등), 약물로 유발된 변비

6) 치료

- “매일 배변해야 한다는 강박관념은 잘못된 & 3일에 1번 배변하면 정상”이라고 반복 교육
- ① 식이요법
- 하루 200cc잔으로 6-8잔 분량의 수분 섭취 - 매일 25-30mg의 섬유소 섭취
- ② 행동요법
- 대장의 운동은 아침 or 식사 후에 가장 활발 ⇒ 아침 식사 시, 음료수 복용 5-15분 후에 변기에 앉아 일정시간 보내도록 함
- 생체 되먹이기 요법
- 기능성 출구폐쇄가 있을 때, 배변 시 골반저가 수축보다 이완할 수 있게 근육을 재교육
- 골반저 근육이 이완돼야 대변이 나올 수 있으므로
- 정신심리요법
- 약물요법

- 여기까지가 중간고사 시험범위이며, 기말고사는 뒤의 '변비 한의학적 고찰: 치료'부터 범위 시작입니다. 시험공부 파이팅입니다.